



El Real Decreto 239/2026 exige acreditación permanente en las consultas de Psicología, la OMS actualiza sus guías sobre el riesgo de demencia y la Psicología del Deporte avanza hacia su reconocimiento: claves del 10 de agosto de 2026

LUNES 10 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

El Real Decreto 239/2026 obliga a las consultas y centros de Psicología a acreditar de forma permanente la titulación de todo su personal sanitario, con plazos que se extienden hasta 2027. La Organización Mundial de la Salud actualiza sus guías de reducción del riesgo de deterioro cognitivo y demencia, ahora centradas en veinte factores modificables. El coordinador de la División de Psicología del Deporte del Consejo General de la Psicología repasa los avances y los retos pendientes para el reconocimiento normativo de esta especialidad. Un nuevo modelo teórico publicado en Neuropsychologia propone un marco de integración multietapa para explicar la afantasia.

Noticias nacionales

NORMATIVA • NACIONAL

El Real Decreto 239/2026 exige acreditación permanente de titulación en las consultas y centros de Psicología

El Real Decreto 239/2026, de 25 de marzo, modifica el Real Decreto 1277/2003 e incorpora un nuevo artículo 7 bajo el título «Garantías de atención sanitaria», publicado en el Boletín Oficial del Estado. La norma afecta directamente a las consultas sanitarias de Psicología, a los centros sanitarios de Psicología y a los centros multidisciplinares con unidades asistenciales de Psicología. Hasta ahora la comprobación de la titulación se realizaba principalmente en el momento de la autorización o de la renovación del centro; con la nueva regulación, esa obligación pasa a ser permanente y podrá comprobarse en cualquier momento por las autoridades sanitarias competentes. Los centros deberán acreditar que la atención es prestada por profesionales con el título de Especialista en Psicología Clínica, cuando la actividad corresponda a esa especialidad, o con el título de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria junto con el Grado o la Licenciatura en Psicología, cuando la actividad se desarrolle en el ámbito de la Psicología General Sanitaria. La obligación de mantener un expediente personal actualizado alcanza a todo el personal sanitario, independientemente de su modalidad contractual, de si trabaja de forma presencial o mediante telepsicología, o si presta servicios de forma puntual o por sesiones. La disposición adicional primera fija el 1 de enero de 2027 como fecha límite para que los centros dispongan de esta información actualizada, dado que la entrada en vigor de la norma se produjo el 1 de julio de 2026. Las comunidades autónomas disponen, por su parte, de un año adicional, hasta el 1 de julio de 2027, para adaptar la oferta asistencial recogida en los anexos del Real Decreto 1277/2003.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

La Psicología del Deporte avanza hacia su reconocimiento como especialidad, según la PACFD del Consejo General de la Psicología

Enrique Cantón Chirivella, doctor en Psicología, profesor titular de la Universitat de València y coordinador de la División de Psicología de la Actividad Física y el Deporte (PACFD) del Consejo General de la Psicología de España, repasa en una

entrevista publicada en la Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico la evolución de esta especialidad desde el Coloquio Ibérico Internacional de Psicología del Deporte celebrado en Madrid en 1984. Según explica, la disciplina ha pasado de un enfoque tradicionalmente vinculado a la psicopatología a otro centrado en la promoción de la salud y el bienestar psicológico de los deportistas. Cantón destaca avances como la puesta en marcha, en 2017, del proceso nacional de acreditación como Experto o Experta en Psicología del Deporte, al que se sumó posteriormente el certificado europeo EuroPsy Specialist in Sport Psychology impulsado por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, así como acuerdos recientes con el Comité Olímpico Español y con LaLiga. No obstante, señala que la consolidación definitiva de la especialidad pasa por su reconocimiento normativo, lo que exige primero un consenso amplio entre el Consejo General de la Psicología y la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Psicología, y después trasladar esa demanda al ámbito político para promover los cambios legislativos necesarios. El coordinador de la PACFD subraya también la necesidad de delimitar con claridad las competencias del psicólogo o psicóloga del deporte frente a otros perfiles del ámbito deportivo, como entrenadores, fisioterapeutas o médicos, y advierte de que en muchos casos siguen siendo los propios deportistas quienes contratan directamente estos servicios, en lugar de que las organizaciones los incorporen de forma estable a sus equipos técnicos.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), citando la Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico

Noticias internacionales

SALUD PÚBLICA · INTERNACIONAL

La OMS publica la segunda edición de sus guías para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia

La Organización Mundial de la Salud presentó el 15 de julio de 2026 la segunda edición de sus guías sobre reducción del riesgo de deterioro cognitivo y demencia, que actualizan la primera edición publicada en 2019. El documento,

elaborado por el equipo de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OMS, amplía el número de factores de riesgo modificables abordados e introduce, por primera vez, recomendaciones específicas sobre la reducción de la exposición a factores de riesgo ambientales y sobre la aplicación de intervenciones multidominio adaptadas a cada persona. Según recoge la revista *The Lancet Neurology*, la nueva edición reconsidera las recomendaciones de la primera y amplía su alcance para incluir la demencia asociada al ictus, al traumatismo craneoencefálico y al VIH. Las guías cubren intervenciones sobre veinte factores de riesgo potencialmente modificables, agrupados en cuatro categorías: la promoción de conductas saludables, el manejo de determinadas condiciones de salud asociadas a un mayor riesgo, la reducción de la exposición a factores ambientales y la implementación de intervenciones multidominio. La OMS incorporó además, por primera vez en este ámbito, la metodología GRADE para valorar la certeza de la evidencia y la fuerza de cada recomendación. La propia OMS recuerda que no existe todavía un tratamiento curativo ampliamente disponible para la demencia, por lo que la prevención y la reducción del riesgo a lo largo de la vida se mantienen como la estrategia más eficaz para reducir su incidencia futura. El documento identifica también las áreas en las que la evidencia todavía resulta insuficiente y señala la necesidad de más investigación.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Publicaciones científicas recientes

Scholz, C. O., Monzel, M., Kvamme, T. L., Liu, J., & Silvanto, J. (2026). An integration model of mental imagery and aphantasia: Conceptual framework, neuromechanistic pathways, and clinical implications. *Neuropsychologia*, 225, 109401.

DOI: [10.1016/j.neuropsychologia.2026.109401](https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2026.109401)

Hallazgo: Se trata de un artículo teórico, no de un estudio con muestra empírica: los autores, procedentes de la Ruhr-Universität Bochum, la Universidad de Bonn, la Universidad de Aarhus y el Paris Brain Institute, proponen un nuevo marco conceptual para explicar la afantasia, la ausencia marcada o completa de imaginación mental. Frente a las explicaciones que atribuyen la afantasia a un fallo en la reactivación sensorial o a la existencia de

una imaginiería inconsciente, el modelo de integración plantea que la información sensorial reactivada debe pasar por varias etapas de integración antes de dar lugar a una experiencia de imaginiería consciente. Según esta propuesta, las activaciones neuronales observadas en personas con afantasia no constituirían imaginiería propiamente dicha, sino «precursores sensoriales»: códigos sensoriales rudimentarios que todavía no alcanzan estatus perceptivo. Solo cuando estos precursores se integran localmente pasan a ser representaciones perceptivas y, solo cuando estas representaciones se integran a su vez con señales interoceptivas, dan lugar a una experiencia consciente de imaginiería.

Implicación clínica: Los propios autores plantean que este modelo puede ayudar a unificar las explicaciones centradas en la atención y las centradas en la interocepción que se habían propuesto por separado en los últimos años, y que podría orientar la distinción de subtipos dentro de la afantasia, como los casos de imaginiería inconsciente frente a la ausencia total de imaginiería. Los autores sugieren también que el marco podría orientar la exploración de la relevancia clínica de la afantasia, aunque, al tratarse de una propuesta teórica, señalan que todavía requiere de más investigación empírica que la ponga a prueba.

Prioridades del día

Revisar la documentación acreditativa del equipo

Puede ser útil revisar, en consultas y centros con más de un profesional, si el expediente de cada persona (incluidas colaboraciones puntuales o telemáticas) recoge la titulación y la habilitación sanitaria exigida por el Real Decreto 239/2026, antes de que se cumplan los plazos previstos.

Incorporar el cribado de factores de riesgo cognitivo en personas mayores

Puede ser relevante explorar, en la práctica con personas mayores, cómo incorporar información sobre los factores de riesgo modificables de deterioro

cognitivo recogidos en las nuevas guías de la OMS, siempre de forma coordinada con el resto del equipo de salud.

Valorar la delimitación de competencias en equipos multidisciplinares

Puede ser oportuno revisar, en el trabajo con equipos deportivos o multidisciplinares, cómo queda delimitada la función propia de la Psicología frente a la de otros perfiles profesionales, en línea con lo señalado por la PACFD del Consejo General de la Psicología.